

	SOLICITUD DE CREATINEMIA Y EVALUACIÓN DE TFGe <i>Procedimientos Imagenológicos con Medios de Contraste Endovenosos</i>	Versión 2.0	Fecha 04/2026
Código: GP1.5-A · Tabla 1	Ref.: Protocolo GP1.5 · ACR Manual on Contrast Media 2024 · SOCHRADI Guía Clínica N°1	DiagnoPRO	

1. OBJETIVO

Establecer los criterios clínicos para determinar cuándo solicitar creatinemia sérica y evaluar la Tasa de Filtración Glomerular estimada (TFGe) antes de la administración de medios de contraste endovenosos, garantizando la seguridad renal del paciente.

2. CRITERIOS PARA SOLICITAR CREATINEMIA SÉRICA

Aplica para procedimientos de TC con contraste yodado y RM con gadolinio. El resultado tiene una vigencia de **30 días**. Si el resultado presentado supera este plazo, el examen debe reprogramarse.

N°	Criterio clínico del paciente	¿Requiere creatinemia?
1	Edad igual o mayor a 60 años	✓ SÍ — Obligatoria
2	Diabetes mellitus con tratamiento farmacológico	✓ SÍ — Obligatoria
3	Hipertensión arterial con uso de IECA, ARA-II o diuréticos	✓ SÍ — Obligatoria
4	Enfermedad renal crónica conocida o paciente monorreno	✓ SÍ — Obligatoria
5	Trasplante renal	✓ SÍ — Obligatoria
6	Insuficiencia cardíaca	✓ SÍ — Obligatoria
7	Uso de metformina (obligatorio, sin excepción de edad u otros factores)	✓ SÍ — Obligatoria
8	Uso crónico de AINES o medicamentos nefrotóxicos	✓ SÍ — Obligatoria
9	Mieloma múltiple o neoplasia activa en tratamiento con quimioterapia	✓ SÍ — Obligatoria
—	<i>Ninguno de los criterios anteriores está presente</i>	NO REQUERIDA

● **Si el resultado de creatinemia está vencido (más de 30 días), el examen NO puede realizarse.**
Se debe reprogramar y solicitar al paciente un examen de creatinemia actualizado antes de la nueva fecha.

3. DECISIÓN CLÍNICA SEGÚN RESULTADO DE TFG_e (CKD-EPI)

Una vez obtenido el resultado de creatinemia sérica, el tecnólogo médico calculará la TFG_e mediante la fórmula **CKD-EPI**. La decisión de administrar o no el contraste se determinará según los siguientes rangos:

TFG _e (mL/min/1,73 m ²)	TC con contraste iodado	RM con gadolinio (Dotarem)
≥ 30 mL/min/1,73 m ²	✓ Proceder con el examen Sin restricción por función renal. Si usa metformina: administrar contraste y suspender metformina por 48 h post examen.	✓ Proceder con el examen Sin restricción por función renal.
< 30 mL/min/1,73 m ²	✗ NO administrar contraste Derivar al médico solicitante. Dejar constancia escrita de la evaluación riesgo/beneficio en el sistema de gestión.	✗ NO administrar contraste Solo con autorización expresa del médico tratante y evaluación riesgo/beneficio documentada por el radiólogo.
Diálisis crónica	⚠ Puede realizarse con precaución Coordinar el examen antes de la sesión de diálisis programada.	✗ NO administrar contraste Solo con autorización expresa del médico tratante y evaluación riesgo/beneficio documentada por el radiólogo.

i Consideración institucional Diagnopro:

Se utiliza Dotarem® (gadoterate meglumine), agente macrocíclico Grupo II según clasificación ACR, con muy bajo riesgo de Fibrosis Sistémica Nefrogénica (FSN). No obstante, por política institucional no se administrará gadolinio con TFG_e < 30 mL/min/1,73 m² salvo las excepciones indicadas en la tabla anterior.

4. CASO ESPECIAL: PACIENTE EN TRATAMIENTO CON METFORMINA

Esta indicación aplica **únicamente a TC con contraste iodado**. No aplica a RM con gadolinio.

Situación clínica	Conducta a seguir
TFGe ≥ 30 mL/min/1,73 m ² sin injuria renal aguda	1. Administrar el contraste iodado con normalidad. 2. Informar al paciente que debe suspender la metformina y sus derivados. 3. NO reanudar metformina hasta 48 horas después del examen. 4. Esta indicación debe quedar reflejada en las instrucciones post examen entregadas al paciente (Anexo 4).
TFGe < 30 mL/min/1,73 m ² o injuria renal aguda conocida	1. NO administrar el contraste iodado. 2. Derivar al médico solicitante para reevaluación.

5. RECORDATORIO OPERATIVO

- ✓ **Antes de cada examen con contraste, el tecnólogo médico deberá:**
- a) Verificar si el paciente cumple alguno de los criterios de la Sección 2.
 - b) Solicitar o revisar el resultado de creatinemia sérica vigente (≤ 30 días).
 - c) Calcular la TFGe con la fórmula CKD-EPI.
 - d) Determinar la conducta según los rangos de la Sección 3.